Дар, риск и доверие

Етични проблеми при трансплантацията на органи и при научните изследвания с хора

Упражнение 6 · CMME — I част · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Пет въпроса за днешното упражнение

1. Трансплантация: понятия и смърт
2. Етични проблеми в трансплантацията
3. Трансплантацията в българското право
4. Етика на научните изследвания с хора
5. Научните изследвания в правото на ЕС и България

Трансплантация: понятия и смърт

Трансплантация: понятие и видове

Вид	Произход на присадката	Характерен етичен въпрос
Автотрансплантация	Същият човек	Съгласие и съразмерност на риска
Изотрансплантация	Еднояйчен близнак	Доброволност на донора
Алотрансплантация	Друг човек — жив или починал	Съгласие, справедливо разпределение, безвъзмездност
Ксенотрансплантация	Животно	Инфекциозен риск за обществото, проследяване, отношение към животните

ЗТОТК, чл. 2: вземане от труп или от живо лице и присаждане на друго лице **с лечебна цел**.

Донорът: жив или починал

Жив донор

Чифтен орган, част от самовъзстановяващ се орган, тъкани и клетки. Операция на здрав човек без пряка телесна полза.

Мозъчна смърт

Необратимо спиране на всички функции на главния мозък при поддържана сърдечна дейност. **Не е кома**.

Циркулаторна смърт (DCD)

След необратимо спиране на кръвообращението. Решението за спиране на лечението е независимо от донорството.

Смъртта се установява по едни и същи критерии за всеки пациент — независимо дали е възможно донорство.

Правилото за починалия донор

Какво изисква

Жизненоважен орган се взема само след надлежно установена смърт. Вземането не причинява смъртта.

Как го гарантира законът

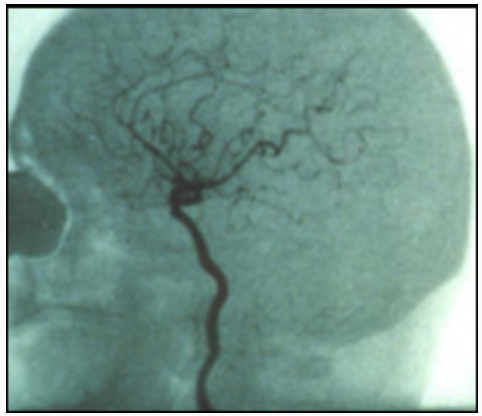
Комисия от трима лекари, назначена със съгласие на ИАМН (ЗТОТК, чл. 18, ал. 2); те не участват във вземането и присаждането (ал. 3).

„Ако приживе съм дал съгласие чрез донорска карта, ще направят ли лекарите всичко възможно да спасят живота ми?“

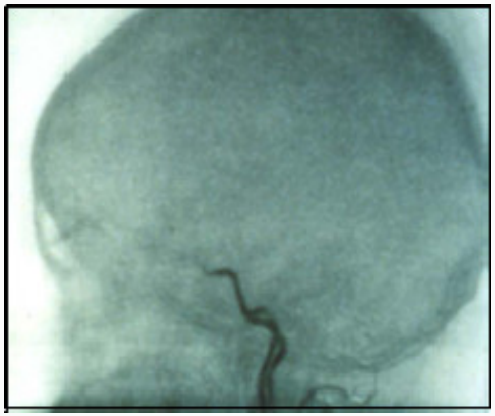
„Лекарите полагат максимални грижи за спасяването на човешкия живот, тъй като това е тяхно морално задължение и право.“

Източник: ИАМН, iamn.bg — Често задавани въпроси, свързани с трансплантацията и донорството

Мозъчна смърт: как се установява



А) Ангиография на съдовете в главния мозък — **наличие** на мозъчно кръвообращение



Б) Ангиография на съдовете в главния мозък — **липса** на мозъчно кръвообращение

Източник: ИАМН, iamn.bg — Често задавани въпроси, свързани с трансплантацията и донорството

МОЗЪЧНА СМЪРТ

Липса на спонтанно дишане · Невъзвратима загуба на функционирането на мозъка, включително и на мозъчния ствол · Липса на мозъчно кръвообращение

- Комисия от трима лекари (АИЛ, неврология, неврохирургия, рентгенология)
- Не започва при хипотермия, интоксикация, миорелаксанти
- Два клинични прегледа през ≥ 12 часа или с ЕЕГ / тест за кръвоток
- Тестът за кръвоток е задължителен при деца до 6 години

Наредба № 14 от 15.04.2004 г., чл. 8–14

Етични проблеми в трансплантацията

Модели на съгласие за донорство след смъртта

Изрично съгласие (opt-in)

Донор е само който приживе е заявил желание. Уважава активния избор; дава по-малко донори.

Предполагаемо съгласие (opt-out)

Донорството е допустимо, ако човекът не е заявил отказ. Етично е само при информирани граждани и лесен отказ.

България — предполагаемо съгласие с гаранции: прижизнено писмено несъгласие, вписано в регистъра на ИАМН (ЗТОТК, чл. 19–20); задължително уведомяване на близките, чийто писмен отказ спира вземането — първо съпруг или родител, после деца, братя и сестри (чл. 21); под 18 г. — само с писмено съгласие на родителите (чл. 19, ал. 2).

Как гражданинът заявява несъгласие

Здравноосигурен, с личен лекар

Декларация по образец, подписана пред **личния лекар** → Вписване в здравно-осигурителната книжка; до 7 дни — до **РЗИ** → До 7 дни РЗИ уведомява **ИАМН** → До 3 дни — вписване в **служебния регистър** на ИАМН

Без личен лекар или без здравни осигуровки

Декларация в **общината** по постоянен адрес, в 2 екземпляра → До 7 дни общината изпраща екземпляр до **ИАМН** → Вписване в **служебния регистър** на ИАМН

Несъгласието може да е за всички или за определени органи и цели (ал. 2). Лекарите проверяват регистъра денонощно. **2 858 души** са заявили несъгласие от 2005 г. до 06.10.2026 г.

ЗТОТК, чл. 20; образец на декларация (заповед РД-01-387/10.08.2022 г.) и статистика: ИАМН, iamn.bg

Казус 1 · Желанието приживе

> Мъж на 24 години е с установена мозъчна смърт след пътна травма. В регистъра няма отказ, а в портфейла му има донорска карта. Родителите потвърждават, че е подкрепял донорството. Когато процедурата става реална, майката не може да го понесе, а бащата представя писмен отказ.

- Каква е моралната и каква — правната тежест на донорската карта?
- Какво следва от чл. 21 ЗТОТК при писмения отказ на бащата?
- Как екипът говори с родителите, без да ги притиска?

Живият донор: самостоятелен пациент

Доброволност

Нотариално заверено съгласие (ЗТОТК, чл. 24, ал. 1); информира лекар извън екипа (ал. 3); оттегляне по всяко време до вземането (ал. 4); разговор насаме.

Защита от риск

Без опасност за живота (ал. 1); комисия от трима лекари извън екипа (ал. 7); дългосрочно проследяване.

Кой може да дари

Пълнолетен съпруг или роднина до четвърта степен (чл. 26, ал. 1); изключения — с разрешение на Етичната комисия по трансплантация (ал. 2).

Без облага

Забрана за плащане (чл. 24, ал. 8); само компенсация на разходи и загубен доход (ал. 9).

Деца и кръстосано донорство

Дете като донор

Органи от лица под 18 г. — никога (ЗТОТК, чл. 24, ал. 5).
Самовъзстановяващи се тъкани и костен мозък — тесни изключения с разрешение на Етичната комисия по трансплантация (чл. 27, 27а).

Кръстосано донорство

Две несъвместими двойки си разменят донорите. Вземането и присаждането са **едновременни** (чл. 26а, ал. 2; чл. 33а).

Детето не е резерв от тъкани за семейството; дарът не се превръща в дълг.

Справедливо разпределение на оскъдните органи

Допустими критерии

- Съвместимост
- Медицинска спешност
- Очаквана полза
- Време на чакане

Недопустими критерии

- Богатство, известност, медиен натиск
- Етнос, пол, професия
- „Обществена полезност“, морална присъда

Бъбрек (Наредба № 17, прил. 1): кръвна група → HLA съвместимост → сенсибилизация → негативен крос-мач → клинично състояние → време на чакане. Деца — с приоритет за бъбрек от донор до 35 г. ИАМН разпределя органите (ЗТОТК, чл. 11, ал. 5, т. 6).

Пътят на органа: кой какво решава

1 Болницата

Открива потенциален донор в интензивното отделение; координатор по донорство уведомява ИАМН.

2 Комисия от трима лекари

Установява смъртта; не участва в трансплантацията (ЗТОТК, чл. 18).

3 Регистър и близки

Проверка в регистъра на ИАМН; задължително уведомяване на близките (чл. 19–21).

4 Донорът

Кондициониране, изследвания по медицинския стандарт, донорско досие.

5 Комисия към ИАМН

Подрежда реципиентите по алгоритъма, с представител на пациентите; директорът на ИАМН утвърждава.

6 Трансплант. център

Приема до 4 часа или органът отива при следващия; при липса — обмен с чужбина.

ЗТОТК, чл. 18–23; Наредба № 17 от 2004 г., чл. 9а–11; донорско досие и обмен на органи (Евротрансплант, FOEDUS, Румъния): ИАМН, iamn.bg

Търговия, трафик и трансплантационен туризъм

Етичен стандарт

Декларацията от Истанбул (2008, ред. 2018) и принципите на СЗО: безвъзмездност, прозрачност, самоосигуряване на всяка държава с органи.

Българско право

ЗТОТК: органите не са предмет на сделка (чл. 5), забрана за облага (чл. 6). НК: трафик с цел отнемане на орган (чл. 159а); нарушаване на правилата за вземане (чл. 349а).

Купеният орган експлоатира бедния донор. Лечението на завърналия се пациент остава задължение.

Казус 2 · По „другата“ процедура

Мъж на 48 години на хемодиализа чака бъбрек от година. Съобщава на нефролога, че чрез посредник е уговорил трансплантация в частна клиника извън ЕС; цената включва „осигуряване на донор“. Моли за имуносупресивна схема и проследяване след завръщането, при пълна поверителност.

- По какво това се различава от законното лечение в чужбина?
- Какво дължи лекарят преди пътуването?
- Отпада ли задължението за грижа след завръщането?

Трансплантацията в българското право

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

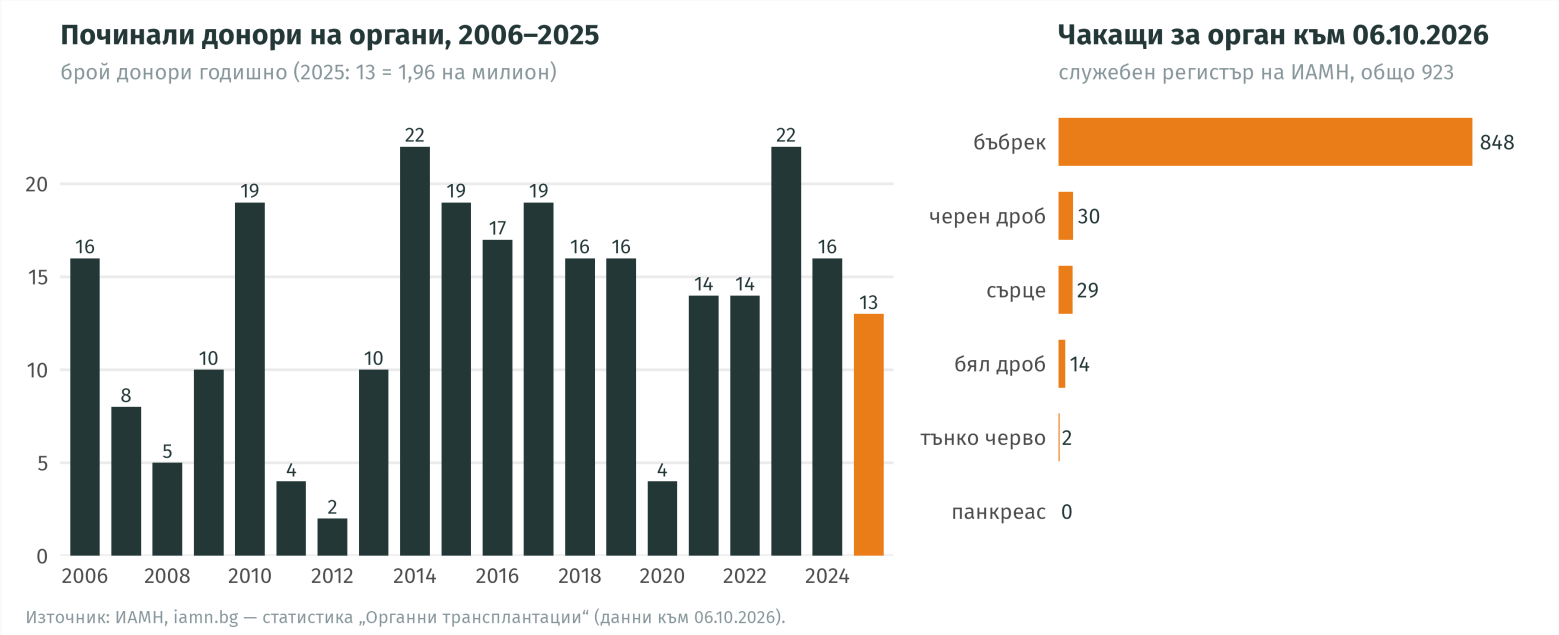
Член	Съдържание
чл. 3, 5, 6	Равни права на пациентите; органите не са предмет на сделка; забрана за облага и реклама
чл. 8	Забрана за разкриване на самоличността на донора и реципиента
чл. 11, ал. 4	ИА „Медицински надзор“ управлява, координира и контролира трансплантацията
чл. 12	Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет
чл. 18–21	Смърт, прижизнен отказ, уведомяване на близките
чл. 24–27а	Жив донор: съгласие, кръг на донорите, деца, кръстосано донорство
чл. 32–33, 39	Регистър на реципиентите, подбор, публичен и служебен регистър

Наредби и институции

Акт	Предмет
Наредба № 14 / 15.04.2004	Медицински критерии и ред за установяване на смърт, включително мозъчна смърт
Наредба № 12 / 4.04.2007	Установяване на обстоятелствата, при които може да се вземе от починал (регистър, близки)
Наредба № 17 / 2004	Служебен регистър на ИАМН за чакащите и подбор на конкретен реципиент
Наредба № 6 / 5.03.2007	Медицински стандарт за трансплантация: донори, изследвания, проследимост
Наредба № 13 / 6.12.2021	Възстановяване на разходите от МЗ, включително на живия донор
Наредба № 2 / 27.03.2019	Лечение и трансплантация в чужбина; одобрение и заплащане от НЗОК

Управление, координация и контрол: ИА „Медицински надзор“ (iamn.bg). **Информация:** портал „Да! За живот!“ (zajivot.bg).

Трансплантацията в България в числа



2026 г. до 06.10: **13 донори, 26 органни трансплантации**. От 2005 г. насам трансплантациите са спасили **1 921 живота** (ИАМН).

Ксенотрансплантация: граници на иновацията

Обещание

Генетично модифицирани животни като източник на органи срещу недостига (първо свинско сърце при човек — 2022).

Проблем

Рискът от нова инфекция засяга близките и обществото; съгласието на един човек не го покрива.

Иновацията изисква научна обоснованост, независима етична оценка и дългосрочно проследяване.

Етика на научните изследвания с хора

Историята като урок

Година	Събитие / документ	Урок
1947	Нюрнбергски кодекс	Доброволното съгласие е задължително; правото да се спре
1932–1972	Тъскиги, САЩ	Измама и отказ от лечение на зависима група
1964 / 2024	Хелзинкска декларация	Етична комисия, уязвимост, регистрация, грижа след изследването
1966	Beecher, NEJM	Неетични изследвания и в демократични държави
1979	Белмонтски доклад	Уважение към личността, благодеяние, справедливост
2016	Насоки на CIOMS	Справедливост при ограничени ресурси, общностно участие

Кога изследването е етично

1 **Социална стойност**

2 **Научна валидност**

3 **Справедлив подбор**

4 **Полза–риск**

5 **Независим преглед**

6 **Информирано съгласие**

7 **Уважение към участника**

Закон за здравето, чл. 197, ал. 3 и 5: изследваното лице има всички права на пациент; неговите интереси са по-важни от научните и финансовите интереси на изследователя.

Лошият дизайн е етичен проблем: рискът остава, ползата изчезва.

Информирано съгласие за участие

Какво трябва да знае участникът

Цел и експериментален характер; рандомизация и плацебо; рискове и ползи; алтернативи; данни; обезщетение; право на оттегляне без загуба на грижа.

Терапевтична заблуда

Убеждението, че протоколът е избран за моето лечение. Изследователят разграничава грижа от наука и проверява разбирането.

Закон за здравето, чл. 199: писмено съгласие след писмено уведомяване; дава се лично; може да се оттегли по всяко време.

Уязвимост, рандомизация и плацебо

Уязвими участници

Деца, недееспособни, бременни, лишени от свобода, студенти и служители, зависими пациенти. Закон за здравето, чл. 200: не се изследват недееспособни; бременни и лишени от свобода — само при очаквана значима полза за тях.

Рандомизация и плацебо

Рандомизацията изисква клинична неопределеност. Плацебо — при липса на доказано лечение или без риск от сериозна или необратима вреда (Хелзинки 2024).

Комисии по етика и Добра клинична практика

Комисия по етика

Независима, с немедицински членове. Оценява преди началото и следи по време на изследването.

Възложител

Организира, финансира, наблюдава; застрахова; носи отговорност при спазен протокол.

Главен изследовател

Провежда изследването в центъра; съгласие; медицински решения; документация.

Добрата клинична практика защитава и участниците, и надеждността на данните.

Казус 3 · „Това е най-новото лечение“

Онколог предлага на пациента си участие във фаза II на клинично изпитване. Нарича продукта „най-новото лечение“ и подчертава по-честите изследвания, но не казва, че ефектът не е доказан. Пациентът подписва и казва на семейството, че лекарят е избрал най-доброто за него. Онкологът получава плащане за всеки включен участник.

- Има ли терапевтична заблуда? Как се коригира?
- Какви интереси трябва да се декларират?
- Трябва ли съгласието да се проведе отново?

Научните изследвания в правото на ЕС и България

Клинични изпитвания на лекарствени продукти

Регламент (ЕС) № 536/2014

Единно подаване в портала CTIS; прилага се от 31.01.2022 г., за всички изпитвания — от 31.01.2025 г.

ЗЛПХМ

Разрешение от ИАЛ (чл. 81, 84); етично становище от Етичната комисия за клинични изпитвания към министъра (чл. 83, 103).

Съгласие

Писмено (чл. 96); за малолетни — двамата родители, за непълнолетни — и самото лице (чл. 97). Отказът на детето се зачита.

Отговорност

Застраховка (чл. 91); възложителят — при спазен протокол, главният изследовател — при неспазен (чл. 92).

Медицински научни изследвания по Закона за здравето

Член	Съдържание
чл. 197	Изследваното лице има права на пациент; интересите му са водещи
чл. 198	Забрани: без доказана безопасност, при повишен риск, изменения в генома
чл. 199	Писмено, лично, оттегляемо информирано съгласие
чл. 200	Не върху недееспособни; бременни и лишени от свобода — само при значима полза
чл. 201	Солидарна отговорност на ръководителя и екипа; задължителна застраховка
чл. 203	Положително становище на местна комисия по етика в заведението

Два режима, две комисии

	Клинично изпитване на лекарствен продукт	Друго медицинско научно изследване
Право	Регламент (ЕС) № 536/2014; ЗЛПХМ, чл. 81–107а	Закон за здравето, чл. 197–205
Разрешение	ИАЛ чрез CTIS	—
Етична оценка	Етична комисия за клинични изпитвания към министъра	Местна комисия по етика в заведението
Съгласие	Писмено; специални правила за деца и недееспособни	Писмено, лично; недееспособни не участват

Терминът е **клинично изпитване** — не „клинично изследване“.

Дарът и участието са доброволни.

Правилата съществуват, за да остане доверието.